



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

PEDOMAN ETIK KEPERAWATAN RS PRIMA HUSADA

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan

Telp. 0343 - 6745000

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

**Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada
Nomor 916/RSPHS/I-KEP/DIR/XI/2025**

**Tentang
Pedoman Etik Keperawatan**

Penanggung Jawab



(Lilo Palupi, AMd.Kep)

Disetujui Oleh :
Authorized Person



(Dr. dr. Aslichah,M.Kes,AFP)

Ditetapkan Oleh :
Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo



(Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep.Ns.,M.Kep)

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Pedoman Etik Komite Keperawatan ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Pedoman Etik Komite Keperawatan merupakan salah satu dokumen penting yang berfungsi sebagai acuan bagi Komite Keperawatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, khususnya dalam pembinaan, pengawasan, serta penegakan etika profesi keperawatan di rumah sakit. Pedoman ini disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kode etik profesi perawat, standar profesi, standar pelayanan rumah sakit, serta ketentuan akreditasi rumah sakit.

Penerapan nilai-nilai etika profesi merupakan landasan utama dalam penyelenggaraan pelayanan keperawatan yang profesional, aman, bermutu, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Oleh karena itu, seluruh anggota Komite Keperawatan, perawat, dan tenaga kesehatan terkait diharapkan dapat memahami, menghayati, dan melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam pedoman ini secara konsisten dan bertanggung jawab.

Pedoman ini juga diharapkan dapat menjadi sarana untuk membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hak pasien dan sesama tenaga kesehatan. Dengan demikian, pelayanan keperawatan yang diberikan dapat memenuhi harapan masyarakat serta mendukung peningkatan mutu pelayanan rumah sakit secara berkelanjutan.

Kami menyadari bahwa pedoman ini masih memerlukan penyempurnaan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, regulasi, dan kebutuhan organisasi. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Pedoman Etik Komite Keperawatan ini. Semoga pedoman ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat dalam mewujudkan pelayanan keperawatan yang profesional, beretika, dan berkualitas baik.

Malang, 1 November 2025
Direktur RS Prima Husada Sukorejo



Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep.,M.Kep

TIM PENYUSUN

1. Ns. Nur Lailatul Farida, S.Kep
2. Ns. Sisca Puspitasari, S.Kep
3. Nisfil Fitria, AMd.Kep
4. Siti Maysaroh, AMd.Kep
5. Debi Firmanasia, AMd.Kep
6. Ninis Indrawati, S.Tr.Keb
7. Sinta Olivia Rahayu, S.Kep.Ns
8. Aini Nur Rohmah, AMd.Kep
9. Nila Martiasani, AMd.Kep
10. Ns. Lilo Palupi, S.Kep

DAFTAR ISI

SAMPUL.....i

PENGESAHANii

KATA PENGANTAR.....iii

TIM PENYUSUNiv

DAFTAR ISI.....v

DAFTAR TABEL.....vi

PERATURAN DIREKTURvii

BAB I PENDAHULUAN.....1

 1.1 Latar Belakang.....1

 1.2 Maksud dan Tujuan1

 1.3 Ruang Lingkup.....2

BAB II TATA LAKSANA3

 2.1 Prinsip Dasar Etik Keperawatan3

 2.2 Etika Dalam Praktik Keperawatan.....5

 2.3 Penegakan dan Pembinaan Etik.....6

BAB III DOKUMENTASI DAN PELAPORAN9

 3.1 Penerimaan Laporan Pelanggran Etik9

 3.2 Klarifikasi dan Pelaporan9

 3.3 Pembahasan Rapat Komite Etik9

 3.4 Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Etik9

 3.5 Pelaksanaan Tindak Lanjut dan Monitoring9

 3.6 Pelaporan Berkala9

BAB IV PENUTUP10

DAFTAR TABEL

Tabel 2.3.1 Daftar Klasifikasi Pelanggaran Etik..... 7



**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO
NOMOR 916/RSPHS/I-KEP/DIR/XI/2025**

TENTANG

PEDOMAN ETIK KEPERAWATAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA,

- Menimbang : a. bahwa tenaga keperawatan merupakan bagian integral dari tenaga kesehatan yang memiliki tanggung jawab profesional dalam memberikan asuhan keperawatan yang bermutu, beretika dan berorientasi pada keselamatan pasien;
- b. bahwa dalam pelaksanaan praktik keperawatan diperlukan pedoman etik sebagai acuan bagi seluruh tenaga keperawatan agar senantiasa menjunjung tinggi nilai moral, integritas, dan tanggung jawab profesi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo tentang Pedoman Etik Keperawatan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pengembangan Jenjang Karir Profesional Perawat Klinis;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/425/2020 tentang Standar Profesi Perawat.
6. Kepdirjen Nomor HK.02.02.D.43961.2024 tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit;
7. Kepdirjen Nomor 43961.2024 tentang Revisi 02 Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit 7 Agustus 2024;
8. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 1110/DPM/I-KEP/DIR/XI/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO TENTANG PEDOMAN ETIK KEPERAWATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1
Pengertian**

Dalam Pedoman Etik Keperawatan ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Etik Keperawatan adalah prinsip moral dan nilai – nilai profesional yang menjadi dasar perilaku perawat dalam memberikan asuhan keperawatan;



- (2) Pelanggaran Etik Keperawatan adalah tindakan perawat yang tidak sesuai dengan nilai, norma atau kode etik profesi;
- (3) Komite Etik dan Disiplin Profesi Keperawatan adalah bagian dari Komite Keperawatan yang bertugas melaksanakan pembinaan, penegakan dan penyelesaian kasus etik dan disiplin profesi keperawatan;
- (4) Perawat adalah tenaga keperawatan yang memiliki izin praktik dan bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan;
- (5) Pasien adalah individu yang menerima pelayanan keperawatan;
- (6) Komite Keperawatan adalah wadah non-struktural rumah sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi.

BAB II TATA LAKSANA

Pasal 2 Prinsip Etik Keperawatan

- (1) Prinsip etik keperawatan yang wajib diterapkan meliputi:
 - a. Otonomi;
 - b. Kebaikan (*Beneficence*);
 - c. Tidak merugikan (*Non Maleficence*);
 - d. Keadilan (*Justice*);
 - e. Kejujuran (*Veracity*);
 - f. Kesetiaan (*Fidelity*);
 - g. Kerahasiaan (*Confidentiality*);
 - h. Akuntabilitas (*Accountability*);

Pasal 3 Etika Dalam Praktik Keperawatan

- (1) Setiap perawat wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan prinsip – prinsip etik keperawatan;
- (2) Setiap tindakan keperawatan harus mencerminkan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan, martabat pasien dan keadilan sosial;
- (3) Komite Etik dan Disiplin Profesi bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan, sosialisasi dan evaluasi penerapan prinsip etik keperawatan secara berkelanjutan.

Pasal 4 Penegakan dan Pembinaan Etik

- (1) Penegakan etik dilakukan apabila terjadi dugaan pelanggaran terhadap kode etik keperawatan atau prinsip – prinsip etik profesi;
- (2) Proses penegakan etik dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan diterima, kecuali terdapat kondisi khusus yang membutuhkan perpanjangan waktu dengan persetujuan Komite Keperawatan;
- (3) Hasil penegakan etik dituangkan dalam berita acara rapat etik dan laporan hasil penegakan etik yang disampaikan kepada Ketua Komite Keperawatan dan Direktur Rumah Sakit;



- (4) Pembinaan etik keperawatan dilakukan untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman dan penerapan nilai etika dalam praktik keperawatan;
- (5) Pembinaan etik bersifat preventif dan kuratif;
- (6) Hasil pembinaan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan program pengembangan profesional berkelanjutan.

BAB III DOKUMENTASI DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Pelanggaran etik atau disiplin dapat dilaporkan oleh pasien, keluarga, sejawat atau pimpinan unit;
- (2) Laporan disampaikan secara tertulis kepada Ketua Komite Keperawatan;
- (3) Identitas pelapor wajib dijaga kerahasiannya.
- (4) Komite Keperawatan melakukan klarifikasi terhadap laporan dan mengumpulkan bukti – bukti;
- (5) Terlapor diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan secara tertulis maupun lisan;
- (6) Pemeriksaan dilakukan secara objektif, adil dan tidak memihak.
- (7) Berdasarkan hasil pemeriksaan, Komite Keperawatan menyusun rekomendasi kepada Direktur Rumah Sakit;
- (8) Direktur rumah sakit menetapkan sanksi atau tindakan pembinaan sesuai tingkat pelanggaran;
- (9) Hasil Keputusan disampaikan secara tertulis kepada pihak terkait.

BAB IV PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 1 November 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



Ns.Heni Indra Wulansari, S.Kep.,M.Kep

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH
SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO
NOMOR 916/RSPHS/I-KEP/DIR/X/2025
TENTANG PEDOMAN ETIK
KEPERAWATAN

PEDOMAN ETIK KEPERAWATAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan keperawatan merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan di rumah sakit yang berorientasi pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia secara holistik dan berkesinambungan. Dalam penyelenggaraan pelayanan keperawatan, perawat dituntut untuk memberikan asuhan yang aman, bermutu, dan beretika, sesuai dengan standar profesi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta meningkatnya kompleksitas pelayanan kesehatan, muncul berbagai tantangan dan dilema etik dalam praktik keperawatan. Situasi tersebut memerlukan panduan yang jelas agar tenaga keperawatan mampu mengambil keputusan yang tepat, profesional, dan tetap berlandaskan pada nilai-nilai etik dan moral profesi.

Untuk menjamin terlaksananya praktik keperawatan yang beretika, diperlukan suatu wadah yang berfungsi menegakkan dan mengawasi penerapan etika profesi di lingkungan rumah sakit. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit, disebutkan bahwa Komite Keperawatan memiliki fungsi utama dalam bidang kredensial, pembinaan mutu profesi, serta etik dan disiplin profesi.

Sebagai pelaksanaan fungsi etik dan disiplin profesi tersebut, Komite Keperawatan berkewajiban menyusun Pedoman Etik Komite Keperawatan sebagai acuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pedoman ini juga merupakan implementasi dari Standar Akreditasi Rumah Sakit (SNARS Edisi 1.1/2), khususnya pada elemen Tata Kelola Profesi (TKP), yang mengharuskan rumah sakit memiliki sistem pembinaan dan penegakan etik profesi yang terstruktur dan terdokumentasi.

Dengan adanya pedoman ini, diharapkan seluruh anggota Komite Keperawatan serta tenaga keperawatan di rumah sakit memiliki arah dan pegangan yang sama dalam menegakkan nilai-nilai etik, menjaga martabat profesi, melindungi keselamatan pasien, serta meningkatkan mutu pelayanan keperawatan secara berkelanjutan

1.2 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud disusunnya Pedoman Etik Keperawatan sebagai acuan bagi tenaga keperawatan dalam bertindak dan mengambil keputusan profesional sesuai dengan nilai moral dan etika keperawatan.

2. Tujuan

- a. Menjamin pelayanan keperawatan diberikan secara profesional, aman, dan beretika.
- b. Meningkatkan kesadaran perawat terhadap tanggung jawab moral dan sosial.
- c. Menjadi pedoman bagi komite etik keperawatan dalam menilai dan menangani kasus etik.
- d. Mendorong budaya integritas, empati dan penghormatan terhadap martabat manusia.

1.3 Ruang Lingkup

Pedoman Etik Keperawatan ini berlaku bagi seluruh tenaga keperawatan di lingkungan rumah sakit, termasuk perawat pelaksana, perawat manajer dalam menjalankan praktik profesional sehari – hari.

Ruang lingkupnya meliputi aspek – aspek:

1. Etika perawat terhadap pasien
2. Etika perawat terhadap sejawat
3. Etika perawat terhadap profesi
4. Etika perawat terhadap institusi
5. Etika perawat terhadap masyarakat.

BAB II

TATA LAKSANA

2.1 Prinsip Dasar Etik Keperawatan

1. Otonomi (*Autonomy*)

Menghormati hak pasien untuk membuat keputusan sendiri mengenai perawatan dan kehidupannya, setelah mendapatkan informasi yang lengkap dan jujur.

a. Tindakan etis

- 1) Memberikan penjelasan yang jelas dan jujur sebelum tindakan keperawatan dilakukan (*informed consent*)
- 2) Menghargai keputusan pasien untuk menolak tindakan medis tertentu.
- 3) Melibatkan pasien dan keluarganya dalam proses perencanaan asuhan keperawatan.

b. Tindakan tidak etis

- 1) Melakukan tindakan tanpa persetujuan pasien
- 2) Menyembunyikan informasi tentang kondisi pasien
- 3) Memaksa pasien menerima intervensi tertentu tanpa memberi pilihan.

2. Kebaikan (*Beneficence*)

Perawat wajib bertindak demi kebaikan pasien dan meningkatkan kesejahteraannya secara holistik (fisik, mental, sosial dan spiritual).

a. Tindakan etis

- 1) Memberikan pelayanan dengan penuh empati, sabar dan peduli.
- 2) Melakukan tindakan keperawatan berdasarkan bukti ilmiah untuk hasil terbaik pasien.
- 3) Membantu pasien memenuhi kebutuhan dasar (nutrisi, kenyamanan, kebersihan)

b. Tindakan tidak etis

- 1) Mengabaikan keluhan pasien karena dianggap sepele.
- 2) Memberikan pelayanan dengan kasar, terburu – buru, atau tanpa empati.
- 3) Tidak menindaklanjuti perubahan kondisi pasien secara tepat.

3. Tidak Merugikan (*Non Maleficence*)

Perawat wajib menghindari tindakan yang dapat membahayakan atau menimbulkan cedera, baik secara fisik maupun psikologi terhadap pasien.

a. Tindakan etis

- 1) Melakukan tindakan sesuai standar prosedur operasional (SPO) dan kompetensi.
- 2) Mengecek identitas pasien sebelum pemberian obat atau tindakan.
- 3) Menggunakan alat medis secara aman dan sesuai petunjuk.

b. Tindakan tidak etis

- 1) Salah memberikan obat karena tidak memeriksa identitas pasien
- 2) Menyentuh pasien tanpa memperhatikan privasinya.
- 3) Mengabaikan protokol keselamatan pasien.

4. Keadilan (*Justice*)

Perawat wajib memperlakukan semua pasien secara adil, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, status sosial, ekonomi atau pandangan politik.

-
- a. Tindakan etis
 - 1) Memberikan perhatian dan pelayanan yang sama kepada semua pasien.
 - 2) Mendahulukan pasien sesuai tingkat kegawatan, bukan status sosial.
 - 3) Menghormati hak pasien dari semua latar belakang budaya.
 - b. Tindakan tidak etis
 - 1) Mengutamakan pasien tertentu karena hubungan pribadi atau imbalan.
 - 2) Mengabaikan pasien miskin atau yang sulit berkomunikasi.
 - 3) Memberikan pelayanan berbeda berdasarkan preferensi pribadi.
5. Menepati Janji/ Kesetiaan (*Fidelity*)
- Menepati janji, komitmen, dan tanggung jawab profesional terhadap pasien, sejawat, dan profesi keperawatan.
- a. Tindakan etis
 - 1) Melaksanaakan janji untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan pasien.
 - 2) Mempertahankan kepercayaan pasien dengan bersikap konsisten dan profesional
 - 3) Menepati jadwal kunjungan atau tindakan keperawatan.
 - b. Tindakan tidak etis
 - 1) Tidak hadir saat pasien membutuhkan sesuai janji
 - 2) Tidak menepati komitmen profesional terhadap tim
 - 3) Mengingkari tanggung jawab yang sudah disepakati
6. Veracity
- Menjunjung tinggi kejujuran dalam komunikasi dengan pasien, sejawat dan tim kesehatan lainnya.
- a. Tindakan etis
 - 1) Menyampaikan informasi secara benar dan sesuai fakta medis.
 - 2) Mengakui kesalahan dalam pelayanan dengan cara yang bertanggung jawab
 - 3) Melaporkan insiden keselamatan pasien dengan jujur dan terbuka.
 - b. Tindakan tidak etis
 - 1) Menyembunyikan kesalahan tindakan yang menyebabkan risiko pasien.
 - 2) Memberikan informasi palsu tentang kondisi pasien.
 - 3) Manipulasi catatan keperawatan atau rekam medis.
7. Confidentiality
- Menjaga kerahasiaan informasi pasien yang diperoleh selama proses asuhan keperawatan kecuali bila diizinkan oleh hukum atau pasien sendiri.
- a. Tindakan etis
 - 1) Menyimpan data pasien ditempat aman dan terbatas aksesnya.
 - 2) Tidak membicarakan kondisi pasien di tempat umum.
 - 3) Memberikan informasi pasien hanya kepada pihak yang berwenang
 - b. Tindakan tidak etis
 - 1) Membocorkan data medis pasien kepada pihak lain tanpa izin
 - 2) Mengunggah informasi atau foto pasien di media sosial
 - 3) Mengobrol tentang kondisi pasien dengan teman atau keluarga di luar pekerjaan.

8. Tanggung jawab (Accountability)

Perawat bertanggung jawab atas setiap tindakan profesional yang dilakukan dan siap mempertanggung jawabkannya secara etik, hukum dan moral.

a. Tindakan etis

- 1) Melaksanakan tindakan sesuai kompetensi dan kewenangan
- 2) Mendokumentasikan setiap tindakan secara benar dan tepat waktu
- 3) Melaporkan kesalahan atau insiden dengan jujur dan bertanggung jawab

b. Tindakan tidak etis

- 1) Melimpahkan kesalahan kepada sejawat
- 2) Melakukan tindakan di luar kewenangan atau tanpa supervisi
- 3) Tidak membuat catatan keperawatan setelah tindakan.

2.2 Etika Dalam Praktik Keperawatan

1. Etika perawat terhadap klien/ pasien

- a. Menghormati hal, martabat, dan nilai – nilai pasien tanpa memandang status sosial, ekonomi, agama atau budaya.
- b. Memberikan pelayanan keperawatan secara aman, kompeten dan berdasarkan standar profesi.
- c. Menjaga kerahasiaan informasi pasien, kecuali diizinkan secara hukum atau oleh pasien
- d. Memberikan informasi yang jujur dan lengkap agar pasien dapat mengambil keputusan secara sadar (*informed consent*)
- e. Menjaga hubungan profesional, tidak memanfaatkan pasien untuk kepentingan pribadi.
- f. Memberikan prioritas terhadap keselamatan pasien diatas kepentingan pribadi atau organisasi.
- g. Menghindari segala bentuk kekerasan verbal, fisik atau emosional terhadap pasien.

2. Etika perawat terhadap sejawat

- a. Menghormati dan mendukung sejawat dalam melaksanakan tugas profesinya.
- b. Tidak menjatuhkan martabat sejawat di depan pasien atau publik.
- c. Memberikan umpan balik yang konstruktif dan profesional.
- d. Mengutamakan kerja sama dalam tim multidisiplin untuk mencapai hasil terbaik bagi pasien.
- e. Menyampaikan laporan atau temuan pelanggaran etik secara objektif melalui mekanisme resmi (bukan gosip atau fitnah).

3. Etika perawat terhadap profesi

- a. Menjaga nama baik profesi keperawatan.
- b. Melaksanakan praktik sesuai standar kompetensi dan kewenangan yang dimiliki.
- c. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan ilmiah, pelatihan, dan pengembangan profesi.
- d. Menolak praktik yang melanggar hukum, moral, atau prinsip profesional.
- e. Tidak menerima imbalan di luar ketentuan yang berlaku untuk memengaruhi keputusan keperawatan.

4. Etika perawat terhadap institusi

- a. Mentaati peraturan dan kebijakan rumah sakit.
- b. Menjaga citra dan reputasi rumah sakit.
- c. Berkontribusi aktif dalam peningkatan mutu pelayanan keperawatan.

- d. Melaporkan setiap pelanggaran etik atau kesalahan praktik sesuai alur pelaporan resmi
- 5. Etika perawat terhadap masyarakat.
 - a. Mengedukasi masyarakat mengenai kesehatan dan keperawatan secara benar dan bertanggung jawab.
 - b. Menghindari penyebaran informasi medis yang menyesatkan.
 - c. Turut serta dalam kegiatan sosial, kemanusiaan, dan kesehatan masyarakat.
 - d. Menjadi teladan dalam perilaku hidup sehat dan bermoral.

2.3 Penegakan dan Pembinaan Etik

- 1. Pembinaan etik
 - a. Dilakukan secara berkesinambungan oleh Komite Etik dan Disiplin Profesi
 - b. Melalui kegiatan:
 - 1) Sosialisasi kode etik
 - 2) Pelatihan dan seminar etik
 - 3) Diskusi kasus etik (*case conference*)
 - 4) Supervisi etik oleh kepala ruang atau manajer keperawatan.
- 2. Penegakan etik
 - a. Penegakan etik dilakukan oleh Komite Etik dan Disiplin Profesi Komite Keperawatan
 - b. Mekanisme penegakan etik meliputi:
 - 1) Penerimaan laporan dugaan pelanggaran etik
 - 2) Klarifikasi dan verifikasi fakta
 - 3) Pemeriksaan oleh tim etik
 - 4) Rapat etik untuk pengambilan keputusan
 - 5) Rekomendasi pembinaan atau sanksi kepada Direktur RS
- 3. Jenis pelanggaran etik
 - a. Pelanggaran ringan

Pelanggaran yang tidak menyebabkan kerugian atau dampak langsung terhadap keselamatan pasien, namun mencerminkan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai moral dan etika profesi.

Tindakan Pembinaan:

 - 1) Teguran lisan atau tertulis
 - 2) Konseling etik oleh atasan langsung
 - 3) Pembinaan perilaku profesional melalui pelatihan komunikasi dan etika kerja
 - b. Pelanggaran sedang

Tindakan yang melanggar prinsip etik utama (kejujuran, tanggung jawab, keadilan atau kerahasiaan) dan berpotensi menimbulkan dampak terhadap keselamatan pasien atau integritas profesi.

Tindakan pembinaan:

 - 1) Teguran tertulis resmi dari Komite Etik
 - 2) Pengawasan langsung oleh kepala ruangan dalam periode tertentu
 - 3) Evaluasi kinerja etik secara triwulan
 - c. Pelanggaran berat

Perilaku yang menyebabkan kerugian serius terhadap pasien, sejawat atau rumah sakit, serta mencoreng citra profesi keperawatan.

Tindakan ini melanggar nilai – nilai moral, hukum dan kode etik secara mendasar.

Tindakan pembinaan:

 - 1) Skorsing sementara dari dinas

- 2) Rekomendasi pencabutan kewenangan klinik oleh Komite Keperawatan.
- 3) Pelaporan ke pihak hukum bila mengandung unsur pidana
- 4) Pemutusan hubungan kerja sesuai ketentuan rumah sakit dan peraturan perundangan.

Tabel 2.3.1 Daftar Klasifikasi Pelanggaran

Tingkat Pelanggaran	Objek Tanggung Jawab	Jenis Pelanggaran
Pelanggaran Ringan	Tanggung jawab terhadap pasien	1. Tidak menyapa pasien saat awal kontak pelayanan 2. Tidak memperkenalkan nama dan peran sebelum melakukan tindakan keperawatan 3. Berbicara dengan nada kurang ramah atau kurang empati 4. Kurang mendengarkan keluhan pasien secara aktif 5. Respon lambat terhadap permintaan pasien yang tidak bersifat gawat darurat 6. Tidak menjelaskan tindakan keperawatan sederhana yang akan dilakukan 7. Kurang menjaga privasi pasien (tirai/penutup tidak ditutup sempurna) 8. Tidak segera membantu pasien dalam kebutuhan kenyamanan dasar 9. Bahasa tubuh atau ekspresi wajah yang menunjukkan ketidaksabaran 10. Berbicara hal pribadi atau bercanda berlebihan di depan pasien 11. Meninggalkan pasien tanpa penjelasan setelah tindakan selesai 12. Tidak menggunakan bahasa yang mudah dipahami pasien 13. Kurang menghargai kebiasaan atau preferensi pasien yang tidak berdampak klinis 14. Mengabaikan keluhan ringan pasien untuk sementara waktu tanpa alasan jelas 15. Kurang menjaga sikap profesional saat berinteraksi dengan keluarga pasien
	Tanggung jawab terhadap tugas	1. Datang terlambat masuk dinas tanpa alasan yang jelas 2. Pulang lebih awal sebelum jam dinas berakhir tanpa izin atasan 3. Tidak mengikuti briefing, atau handover tepat waktu 4. Seragam dinas tidak lengkap atau tidak sesuai ketentuan 5. Tidak menggunakan tanda pengenal (ID Card) saat bertugas 6. Dokumentasi asuhan keperawatan kurang lengkap namun tidak memengaruhi pelayanan 7. Lupa mengisi sebagian formulir keperawatan non-kritis 8. Tidak menjaga kerapihan area kerja perawat 9. Kurang memperhatikan ketertiban administrasi unit 10. Tidak membaca atau memahami pengumuman internal terbaru

		11. Menggunakan ponsel pribadi saat jam kerja untuk kepentingan non-dinas 12. Tidak segera melaporkan ketidakhadiran rekan dinas kepada atasan 13. Tidak mematuhi tata tertib internal unit (misalnya aturan istirahat) 14. Kurang aktif dalam pelaksanaan tugas tambahan ringan yang telah dijadwalkan
	Tanggung jawab terhadap sesama perawat dan profesi lain	1. Tidak menyapa atau bersikap kurang sopan kepada rekan perawat atau profesi lain 2. Komunikasi kurang efektif atau kurang jelas saat handover 3. Nada bicara kurang menghargai rekan kerja 4. Tidak menghormati pendapat atau masukan rekan sejawat 5. Kurang kooperatif dalam kerja tim tanpa menghambat pelayanan 6. Datang terlambat saat rapat tim tanpa alasan jelas 7. Tidak mengikuti briefing lintas profesi secara optimal 8. Mengabaikan etika komunikasi antarprofesi (misalnya menyela pembicaraan) 9. Kurang menghargai peran dan kewenangan profesi lain 10. Bercanda berlebihan yang mengganggu suasana kerja tim 11. Tidak membantu rekan kerja saat beban kerja meningkat (tanpa alasan sah) 12. Menyampaikan kritik secara kurang tepat atau tidak konstruktif 13. Kurang menjaga sikap profesional di area kerja bersama 14. Menggunakan media sosial untuk mengeluh tentang pekerjaan tanpa menyebut nama (namun berpotensi menurunkan suasana kerja) 15. Tidak menjaga etika pergaulan profesional di lingkungan kerja.
	Tanggung jawab terhadap profesi	1. Kurang menjaga citra profesi perawat dalam sikap dan tutur kata 2. Berperilaku kurang profesional di lingkungan kerja 3. Tidak mematuhi etika berpakaian profesi di luar area klinis 4. Kurang aktif mengikuti kegiatan pengembangan profesi internal 5. Tidak membaca atau memahami pedoman profesi yang berlaku 6. Tidak menunjukkan sikap sebagai role model profesi 7. Mengeluh berlebihan tentang profesi di lingkungan kerja 8. Menyampaikan kritik terhadap profesi secara tidak konstruktif 9. Tidak menjaga etika berinteraksi di media sosial terkait profesi 10. Kurang menghormati simbol, atribut, atau identitas profesi 11. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan ilmiah keperawatan tanpa alasan jelas

		12. Kurang menjaga solidaritas dan kebersamaan profesi 13. Menyampaikan informasi profesi yang kurang tepat kepada masyarakat (tanpa niat menyesatkan) 14. Tidak mengikuti arahan pembinaan profesi 15. Kurang menunjukkan tanggung jawab moral sebagai perawat.
Pelanggaran Sedang	Tanggung jawab terhadap pasien	1. Tidak menjelaskan tindakan keperawatan yang akan dilakukan sehingga pasien tidak memahami proses perawatan 2. Tidak memberikan edukasi dasar sesuai kebutuhan pasien 3. Mengabaikan keluhan pasien yang seharusnya ditindaklanjuti 4. Tidak menghormati hak pasien untuk bertanya atau menolak tindakan 5. Kelalaian dalam pemantauan tanda vital atau kondisi pasien 6. Tidak segera melaporkan perubahan kondisi pasien kepada dokter/tim 7. Pelanggaran kerahasiaan pasien secara terbatas (tanpa unsur pidana) 8. Melakukan tindakan keperawatan tanpa informed consent sederhana 9. Komunikasi yang menimbulkan kesalahpahaman serius bagi pasien/keluarga 10. Tidak melibatkan pasien/keluarga dalam perencanaan asuhan 11. Kesalahan prosedur keperawatan yang tidak menimbulkan cedera serius 12. Penundaan tindakan keperawatan yang berdampak pada ketidaknyamanan signifikan 13. Tidak mematuhi prinsip keselamatan pasien (misalnya identifikasi pasien) 14. Bersikap diskriminatif ringan yang mempengaruhi kenyamanan pasien 15. Mengabaikan aspek psikologis pasien yang memerlukan perhatian.
	Tanggung jawab terhadap tugas	1. Tidak menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) keperawatan yang berdampak pada insiden keselamatan pasien (bukan insiden sentinel) 2. Melakukan tindakan keperawatan tanpa koordinasi dengan tim 3. Dokumentasi asuhan keperawatan tidak lengkap dan berulang 4. Kesalahan pemberian obat yang tidak menimbulkan cedera serius 5. Tidak melakukan verifikasi identitas pasien sebelum tindakan 6. Tidak melaksanakan handover sesuai ketentuan 7. Mengabaikan jadwal pemantauan pasien yang telah ditetapkan 8. Tidak melaporkan insiden keselamatan pasien tingkat ringan–sedang 9. Menunda pelaksanaan tugas penting tanpa alasan yang jelas

		10. Melaksanakan tugas di luar kewenangan tanpa dampak berat 11. Tidak mengikuti pelatihan wajib yang telah dijadwalkan 12. Mengabaikan instruksi kerja dari atasan yang sah 13. Tidak melakukan pencatatan penggunaan alat/obat dengan benar 14. Kelalaian dalam menjaga kebersihan dan keamanan alat kerja 15. Tidak melakukan evaluasi asuhan keperawatan sesuai ketentuan.
	Tanggung jawab terhadap sesama perawat dan profesi lain	1. Komunikasi tidak efektif saat handover sehingga menimbulkan kesalahan tindak lanjut 2. Tidak menyampaikan informasi penting pasien kepada perawat berikutnya atau profesi lain 3. Mengabaikan pendapat atau rekomendasi profesi lain yang relevan 4. Bersikap tidak kooperatif dalam tim sehingga menghambat pelayanan 5. Menyalahkan rekan kerja secara terbuka di depan pasien/keluarga 6. Menyampaikan kritik dengan cara tidak profesional dan menimbulkan konflik kerja 7. Tidak menghormati kewenangan dan peran profesi lain 8. Menolak bekerja sama dalam pelayanan pasien tanpa alasan yang sah 9. Konflik antarperawat yang dibiarkan berlarut dan mengganggu kerja tim 10. Tidak menghadiri rapat koordinasi lintas profesi yang bersifat wajib 11. Menggunakan bahasa atau sikap yang merendahkan profesi lain 12. Menghambat alur pelayanan karena tidak mau berkoordinasi 13. Tidak melaporkan kesalahan kerja rekan yang berdampak pada pelayanan 14. Menyampaikan informasi yang berbeda-beda kepada tim sehingga membingungkan 15. Tidak menjaga etika komunikasi antarprofesi dalam situasi pelayanan pasien
	Tanggung jawab terhadap profesi keperawatan	1. Tidak mematuhi kode etik keperawatan dalam praktik sehari-hari 2. Mengabaikan kewajiban pengembangan kompetensi profesi secara berkelanjutan 3. Menolak mengikuti pembinaan profesi tanpa alasan yang sah 4. Menyampaikan informasi keperawatan yang tidak akurat kepada pasien atau masyarakat 5. Menggunakan atribut profesi secara tidak pantas di ruang publik 6. Berperilaku tidak profesional di media sosial yang mencoreng citra profesi 7. Tidak mengikuti pedoman praktik keperawatan yang telah ditetapkan 8. Mengabaikan rekomendasi organisasi profesi dalam praktik keperawatan 9. Konflik kepentingan yang memengaruhi objektivitas praktik keperawatan

		10. Tidak menjaga solidaritas dan etika kolegal sesama perawat 11. Menyalahgunakan jabatan profesi untuk kepentingan pribadi (skala terbatas) 12. Menyampaikan kritik terhadap profesi secara tidak konstruktif di forum publik 13. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan profesi yang bersifat wajib 14. Menghambat proses pembinaan profesi perawat lain 15. Tidak melaporkan pelanggaran etik ringan yang diketahui.
Pelanggaran Berat	Tanggung jawab terhadap pasien	1. Kelalaian berat yang menyebabkan cedera serius atau kematian pasien 2. Melakukan tindakan keperawatan yang tidak sesuai indikasi dan membahayakan pasien 3. Kekerasan fisik, verbal, atau psikologis terhadap pasien 4. Pelecehan seksual atau tindakan asusila terhadap pasien 5. Diskriminasi terhadap pasien berdasarkan latar belakang tertentu 6. Mengabaikan pasien dalam kondisi gawat darurat 7. Memberikan obat atau tindakan yang diketahui berisiko tinggi tanpa pengawasan 8. Melakukan tindakan keperawatan tanpa kompetensi yang memadai sehingga membahayakan pasien 9. Pemalsuan atau manipulasi data kondisi pasien 10. Membocorkan rahasia pasien yang menimbulkan kerugian serius 11. Menghentikan atau menunda perawatan penting tanpa alasan medis 12. Tindakan tidak manusiawi atau merendahkan martabat pasien 13. Mengabaikan standar keselamatan pasien secara sengaja 14. Melakukan tindakan invasif tanpa persetujuan yang semestinya 15. Membiarkan pasien dalam kondisi berbahaya tanpa intervensi yang diperlukan
	Tanggung jawab terhadap tugas	1. Tidak melaksanakan tugas dinas sehingga menyebabkan cedera serius atau kematian pasien 2. Mangkir dari tugas tanpa keterangan yang sah dalam jangka waktu tertentu 3. Melakukan tindakan keperawatan di luar kewenangan dan kompetensi 4. Penyalahgunaan obat, alat medis, atau fasilitas pelayanan kesehatan 5. Pemalsuan dokumen keperawatan atau rekam medis 6. Mengabaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berakibat fatal 7. Kesalahan pemberian obat yang menyebabkan dampak serius 8. Tidak melaporkan insiden keselamatan pasien berat secara sengaja 9. Menghilangkan, merusak, atau memanipulasi alat dan bahan medis

		10. Melaksanakan tugas dalam kondisi tidak layak (misalnya di bawah pengaruh alkohol/narkoba) 11. Menolak melaksanakan tugas penting tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan 12. Kelalaian berulang yang telah dibina namun tetap menimbulkan dampak serius 13. Menyalahgunakan jabatan atau wewenang dalam pelaksanaan tugas 14. Mengabaikan instruksi atasan yang sah hingga mengganggu pelayanan kritis 15. Menyebabkan kerugian besar bagi pasien atau institusi akibat kelalaian tugas
	Tanggung jawab terhadap sesama perawat atau profesi lain	1. Kekerasan fisik atau ancaman serius terhadap rekan perawat atau profesi lain 2. Pelecehan seksual atau perundungan berat (bullying) di tempat kerja 3. Intimidasi yang menyebabkan gangguan psikologis berat atau menghambat pelayanan 4. Sabotase kerja rekan sehingga membahayakan pasien 5. Menyembunyikan kesalahan fatal rekan kerja secara sengaja 6. Menyampaikan fitnah atau tuduhan palsu yang merugikan rekan/profesi lain 7. Menghalangi koordinasi lintas profesi dalam situasi gawat darurat 8. Merendahkan martabat profesi lain secara terbuka dan sistematis 9. Penyalahgunaan jabatan untuk menekan atau merugikan rekan kerja 10. Menolak bekerja sama secara sengaja hingga menyebabkan insiden keselamatan pasien 11. Mengungkap data pribadi rekan kerja untuk tujuan merugikan 12. Konflik serius yang disengaja dan berlarut sehingga merusak kerja tim 13. Tindakan diskriminatif berat terhadap rekan/profesi lain 14. Menghasut konflik antarprofesi yang mengganggu pelayanan 15. Tindakan tidak etis yang berdampak pada sanksi hukum atau disiplin berat
	Tanggung jawab terhadap profesi keperawatan	1. Praktik keperawatan tanpa STR dan/atau SIP yang sah 2. Meminjamkan atau menggunakan STR/SIP milik orang lain 3. Menyalahgunakan profesi perawat untuk kepentingan pribadi atau komersial 4. Pemalsuan dokumen profesi (STR, SIP, sertifikat kompetensi, logbook) 5. Tindakan kriminal yang dilakukan dengan memanfaatkan status sebagai perawat 6. Pelanggaran berat kode etik yang mencoreng kepercayaan publik 7. Memberikan keterangan atau kesaksian palsu atas nama profesi 8. Menghambat atau mengintervensi proses penegakan etik dan disiplin profesi

		9. Menolak putusan Majelis Etik/Disiplin profesi secara sengaja 10. Penyalahgunaan jabatan profesi untuk melindungi pelanggaran berat 11. Perilaku asusila berat yang dilakukan dalam kapasitas sebagai perawat 12. Menyebarkan informasi palsu/ menyesatkan atas nama profesi keperawatan 13. Mengorganisasi atau terlibat dalam praktik keperawatan ilegal 14. Tindakan yang menyebabkan rusaknya citra profesi secara luas 15. Pelanggaran berulang tingkat sedang yang tidak diperbaiki dan berdampak luas 16. Melakukan tindak pencurian 17. Terlibat dalam hubungan personal yang tidak sesuai dengan norma kesetiaan baik dalam rumah tangga, hukum dan nilai kesusilaan yang berlaku
--	--	--

BAB III

DOKUMENTASI DAN PELAPORAN

3.1 Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Etik

1. Sumber laporan dapat berasal dari
 - a. Pasien atau keluarga pasien
 - b. Sejawat keperawatan
 - c. Tim medis atau tenaga kesehatan lain
 - d. Kepala ruangan/ kepala instalasi
 - e. Laporan langsung dari Komite Keperawatan
2. Media pelaporan
 - a. Laporan tertulis
 - b. Laporan elektronik melalui sistem internal rumah sakit
 - c. Laporan lisan yang kemudian dituangkan dalam berita acara oleh petugas etik
3. Petugas penerima laporan
 - a. Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi Keperawatan
4. Langkah dokumentasi awal
 - a. Mencatat laporan
 - b. Menyimpan dokumen ke dalam file perawat

3.2 Klarifikasi dan Pelaporan

1. Komite etik melakukan klarifikasi terhadap pelapor, terlapor dan saksi terkait.
2. Hasil klarifikasi didokumentasikan
3. Bukti pendukung (rekam medis, laporan shift, dsb) dilampirkan secara resmi
4. Semua dokumen disimpan dalam arsip

3.3 Pembahasan Rapat Komite Etik

1. Komite etik melakukan rapat internal untuk membahas hasil klarifikasi
2. Hasil rapat dituangkan dalam Notulen
3. Notulen ditandatangani oleh Ketua Komite Etik dan seluruh anggota yang hadir.

3.4 Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Etik

1. Disusun oleh komite etik berdasarkan hasil rapat
2. Laporan disampaikan kepada :
 - a. Ketua Komite Keperawatan
 - b. Direktur Rumah Sakit

3.5 Pelaksanaan tindak lanjut dan monitoring

1. Komite Keperawatan dan Kepala Rumah Sakit melaksanakan tindakan pembinaan sesuai rekomendasi
2. Setiap hasil tindak lanjut dicatat dan didokumentasikan
3. Dilakukan monitoring untuk memastikan perubahan perilaku dan perbaikan profesionalisme.

3.6 Pelaporan Berkala

1. Komite etik menyusun laporan kegiatan dan rekapitulasi kasus etik setiap Triwulan
2. Laporan disampaikan kepada Direktur Rumah Sakit dan Komite Keperawatan.

BAB IV

PENUTUP

Pedoman Etik dan Disiplin Profesi Komite Keperawatan ini disusun sebagai landasan dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan, serta penegakan etika dan disiplin profesi keperawatan di rumah sakit. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Komite Keperawatan dan seluruh tenaga keperawatan dalam menjalankan praktik profesional yang sesuai dengan kode etik, standar profesi, standar pelayanan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan etika dan disiplin profesi yang konsisten merupakan bagian penting dalam upaya menjaga mutu pelayanan keperawatan, meningkatkan keselamatan pasien, melindungi tenaga keperawatan dalam menjalankan praktik profesinya, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit. Oleh karena itu, diperlukan komitmen, integritas, dan tanggung jawab dari seluruh tenaga keperawatan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai etika profesi dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada pasien.

Komite Keperawatan melalui Subkomite Etik dan Disiplin Profesi berkewajiban melakukan pembinaan, pemantauan, evaluasi, serta memberikan rekomendasi terhadap penyelesaian berbagai permasalahan etik dan disiplin profesi yang terjadi di lingkungan rumah sakit secara objektif, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pedoman ini akan dievaluasi dan disempurnakan secara berkala sesuai dengan perkembangan regulasi, standar profesi, kebutuhan organisasi, serta dinamika pelayanan kesehatan. Dengan demikian, pedoman ini diharapkan senantiasa relevan dan mampu mendukung terwujudnya pelayanan keperawatan yang profesional, beretika, disiplin, bermutu, dan berfokus pada keselamatan pasien.

Demikian Pedoman Etik dan Disiplin Profesi Komite Keperawatan ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Semoga pedoman ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam menciptakan budaya kerja yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada mutu pelayanan serta keselamatan pasien di rumah sakit.

Pasuruan, 1 November 2025

Ketua Komite Keperawatan



Ns. Nur Lailatul Farida, S.Kep

Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi



Lilo Palupi, AMd.Kep

Mengetahui,
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep.,M.Kep